Relatório Final

de Acompanhamento

Estrutura padronizada para integração de telemetria gamificada, métricas cognitivas, contexto clínico e rastreabilidade.

Documento de avaliação neuropsicológica gerado com os biomarcadores digitais Teko.

Sumário

01	Identificação	03
02	Motivo da avaliação	04
03	Metodologia	05
04	Variáveis do modelo	06
05	Resultado dos jogos	07-09
06	Síntese comportamental	10
07	Modelo probabilístico	11
08	Contextualização clínica	12
09	Integração dos achados	13
10	Pontos para consideração profissional	14
11	Conclusão	15
12	Assinatura e rastreabilidade	16

Estrutura padronizada do relatório final com síntese de telemetria, análise comportamental e conduta clínica.

03

Identificação

Nome do paciente
Lucas Gabriel Silva

Idade
8 anos e 4 meses

Gênero
Masculino

Responsável
Helena Silva (Mãe)

Data da aplicação
01/10/2026

Psicólogo(a) responsável
Dra. Mariana Costa

Registro profissional (CRP)
CRP 06/142589

Clínica / Instituição
Centro Teko de Neuropsicologia

Status de completude da bateria
Bateria Completa (100% concluída)

Jogos realizados

- Goleiro (Tempo de Reação Visomotor)
- Toca Rápido (Controle Inibitório Go/No-Go)
- Fotógrafo da Floresta (Atenção Sustentada e Fadiga)

04

Motivo da avaliação

Objetivo da avaliação

Mapear biomarcadores digitais de regulação atencional, tempo de reação visomotor e controle inibitório através da bateria padronizada de jogos sérios da Teko.

Queixa principal

Relatos escolares e familiares apontando inquietação motora, desatenção em tarefas de longa duração e episódios frequentes de impulsividade na execução de deveres de casa.

Contexto inicial resumido

Criança sem diagnósticos consolidados prévios. Rendimento acadêmico oscilante no 3º ano do Ensino Fundamental com boa sociabilidade e curiosidade intelectual.

05

Metodologia

Avaliação Neuropsicológica Baseada em Biomarcadores Digitais
A metodologia Teko combina tarefas computadorizadas estruturadas com registro contínuo da interação visomotora. Ao substituir testes em papel por jogos adaptativos, avalia-se o comportamento natural da criança em tempo real com alta precisão milimétrica.

Descrição metodológica

A bateria Teko utiliza jogos sérios com telemetria contínua de micro-movimentos, tempo de resposta visomotora e taxas de precisão. O ecossistema avalia o perfil cognitivo em ambiente lúdico e engajador, mensurando latências em milissegundos sem sobrecarregar a criança com tarefas monótonas.

Condições da aplicação e qualidade da sessão

Aplicação presencial conduzida em consultório estruturado e silencioso, no período matutino. A criança apresentou excelente cooperação, alta motivação e aderência integral às instruções dos 3 jogos.

06

Variáveis do modelo

1. Variabilidade da Resposta

Mensura a regularidade milissegundo a milissegundo das respostas motoras da criança frente a estímulos visuais rápidos no jogo do Goleiro.

2. Controle Inibitório

Analisa a capacidade de desaceleração e freio motor diante de estímulos No-Go no jogo Toca Rápido.

3. Atenção Sustentada

Avalia a manutenção e persistência do foco ao longo do tempo através da acurácia e lapsos no Fotógrafo da Floresta.

4. Idade e Normalização

Estandardização e normalização estatística dos biomarcadores por faixa etária da população de referência.

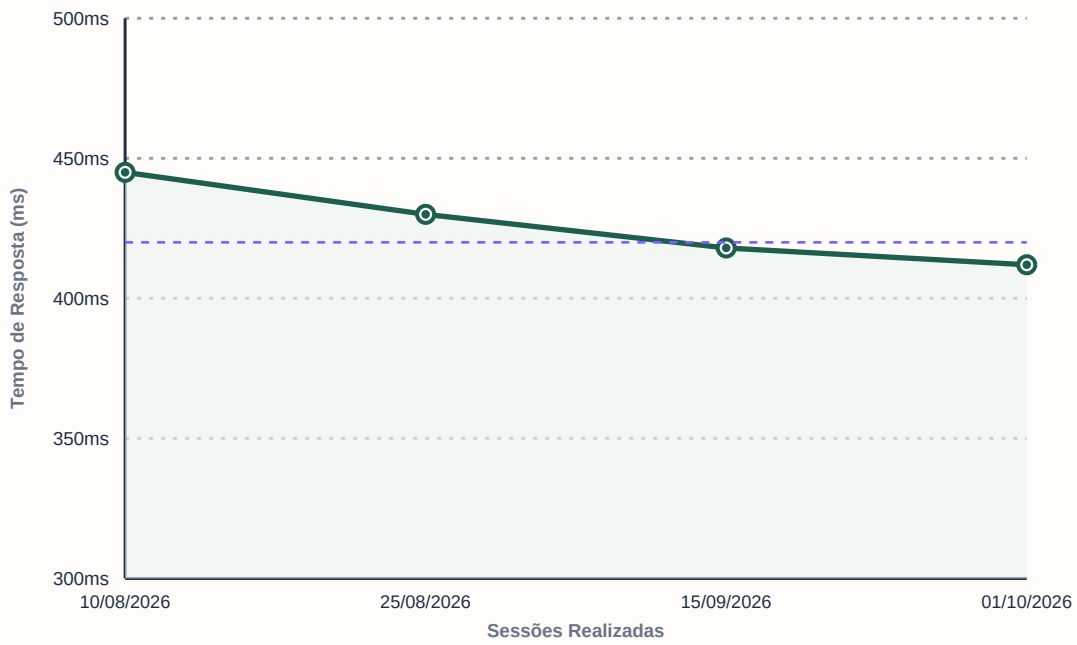
Variáveis efetivamente utilizadas nesta aplicação

Todas as variáveis biométricas de tempo de resposta, controle de inibição e sustentação atencional apresentaram consistência amostral e integridade na telemetria.

07

Resultado dos jogos

Jogo do Goleiro: Tempo de Resposta Visomotor ao Longo das Sessões



Síntese Clínica e Evolução: Jogo do Goleiro

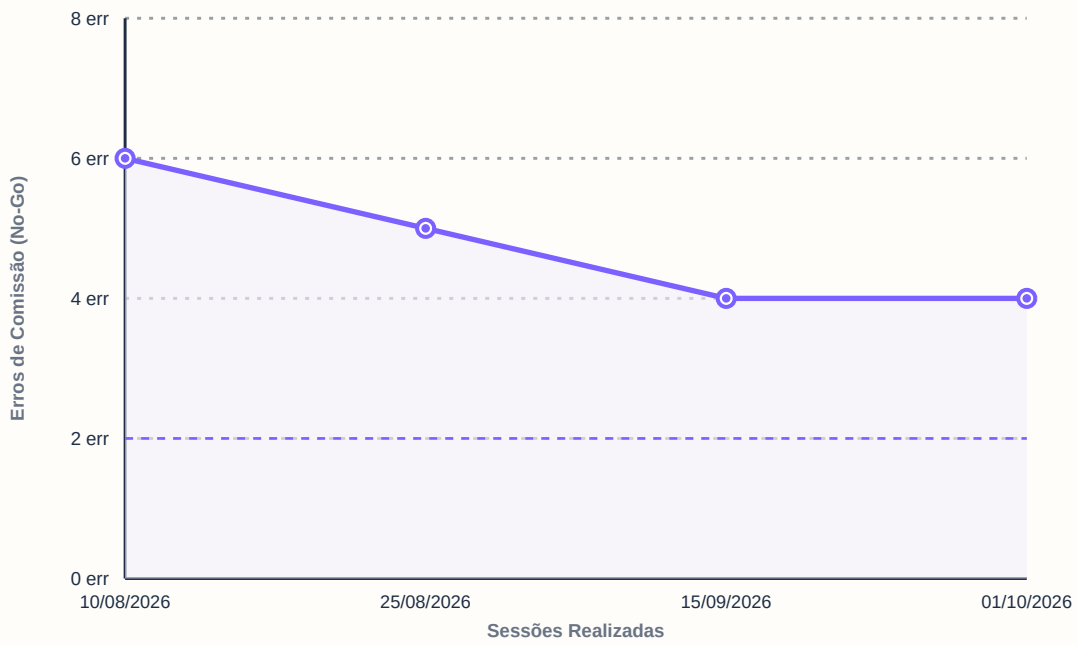
Análise Neurofuncional e Parecer de Desempenho:
Observou-se flutuação moderada nas latências de resposta, com respostas ágeis intercaladas por lapsos transitórios nos blocos mais avançados do jogo. Na análise temporal entre as sessões, nota-se gradativa redução de 445ms para 412ms, indicando prontidão visomotora positiva e atenuação de instabilidade de foco inicial.

Evolução da Trajetória Visomotora: A telemetria contínua evidencia que a criança desenvolve prontidão e estabilidade nas fases iniciais, com oscilação concentrada nos blocos de maior exigência temporal. A redução progressiva de latência ao longo das sessões aponta para capacidade de adaptação positiva sob intervenção direcionada.

08

Resultado dos jogos

Jogo Toca Rápido: Frequência de Erros Inibitórios No-Go ao Longo das Sessões



Síntese Clínica e Evolução: Jogo Toca Rápido

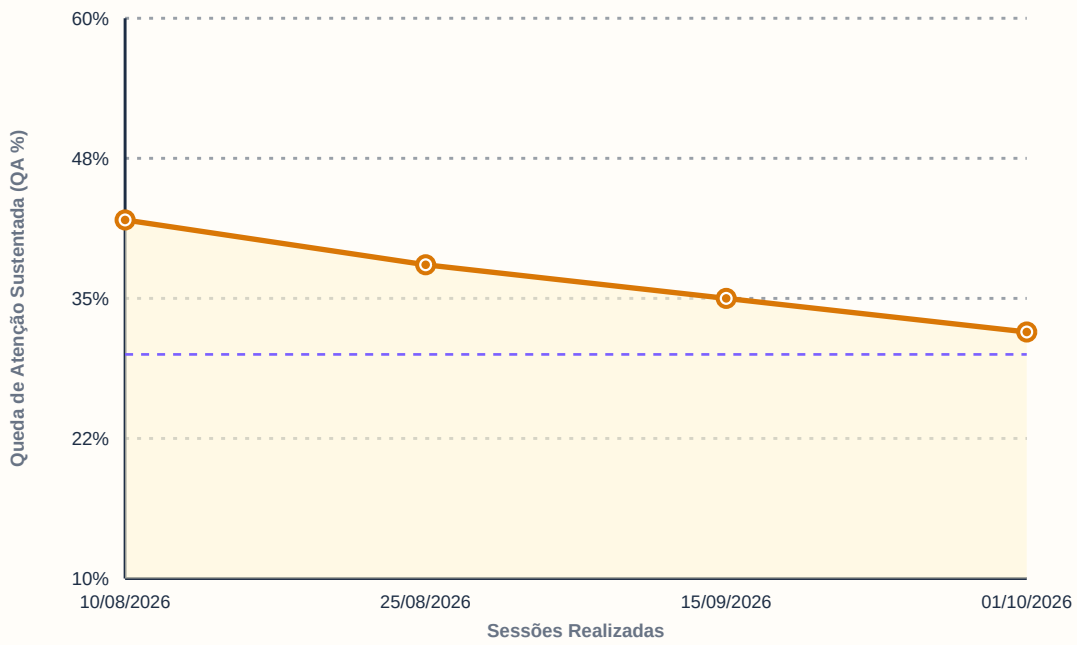
Análise Neurofuncional e Parecer de Desempenho:
A criança demonstrou bom engajamento geral, contudo apresentou tendência a responder precipitadamente antes do processamento inibitório frente aos estímulos No-Go. A curva longitudinal evidencia redução progressiva de 6 para 4 erros de comissão, sugerindo ganho adaptativo de desaceleração motora sob orientação terapêutica.

Evolução do Controle Inibitório: A análise longitudinal confirma diminuição gradativa de disparos automáticos e toques impulsivos, indicando que o freio inibitório responde satisfatoriamente quando a criança recebe reforço estruturado de desaceleração e organização da resposta.

09

Resultado dos jogos

Fotógrafo da Floresta: Índice de Declínio da Atenção (QA) ao Longo das Sessões



Síntese Clínica e Evolução: Fotógrafo da Floresta

Análise Neurofuncional e Parecer de Desempenho:
Evidenciou-se declínio gradativo de acurácia entre os primeiros minutos e o término da atividade, sugerindo aumento de fadiga cognitiva ao longo do tempo. O acompanhamento longitudinal do índice QA demonstra estabilização em torno de 32%, apontando que pausas programadas continuam sendo necessárias para sustentação de rendimento.

Evolução da Sustentação Atencional e Fadiga: A trajetória longitudinal demonstra que a taxa de acurácia sustentada oscila em função da duração contínua da atividade, reforçando a importância clínica de intervalos estratégicos para recarga atencional no cotidiano escolar e domiciliar.

10

Síntese comportamental

1. Variabilidade da resposta

A oscilação no tempo de resposta aponta para momentos transitórios em que o foco oscila, característico de flutuação atencional durante tarefas repetitivas.

2. Controle inibitório

Dificuldade moderada observada na desaceleração motora, gerando toques precipitados em alvos que exigiam suspensão da resposta.

3. Atenção sustentada

Curva descendente de rendimento da metade para o fim da sessão, compatível com fadiga cognitiva precoce sob esforço sustentado.

4. Interpretação conjunta

O perfil integrado evidencia que a impulsividade motora associada à fatigabilidade atencional representa a principal barreira funcional da criança.

11

Modelo probabilístico

Probabilidade Estatística Estimada

68% (Elevada Probabilidade de Perfil Atencional Compatível)

Data da Aplicação: 01/10/2026

Nota Técnica e Ética de Interpretação

A probabilidade informada decorre de modelagem probabilística comparativa fundamentada em biomarcadores digitais de telemetria. **Este resultado NÃO constitui diagnóstico médico fechado ou laudo psiquiátrico definitivo**. Trata-se de um instrumento técnico de triagem padronizado que deve obrigatoriamente ser contextualizado com a avaliação clínica qualitativa, observações comportamentais e anamnese realizada por profissional habilitado.

Fundamentação dos biomarcadores ponderados

O cálculo probabilístico pondera quatro dimensões fundamentais do funcionamento executivo da criança: a variabilidade do tempo de reação (estabilidade do foco), o índice de impulsividade (freio motor no No-Go), a curva de sustentação atencional (fadiga ao longo dos blocos) e a faixa etária de desenvolvimento.

12

Contextualização clínica

Anamnese detalhada (desenvolvimento, histórico escolar, sono, saúde e rotina)

Desenvolvimento motor e da fala dentro dos marcos esperados. Sono agitado relatado pela genitora com despertares noturnos ocasionais. Queixas escolares persistentes desde a transição de ciclo, com dificuldade de conclusão de tarefas em sala de aula.

Notas clínicas e observações do prontuário

Criança curiosa, comunicativa e com intensa busca por novidade sensorial. Necessitou de reforço de instruções verbais para manter o foco na tela durante as transições de fases.

Histórico das sessões e evolução das aplicações

Registro de sessões sucessivas com curva de adaptação motora positiva, mantendo o padrão de oscilação atencional sob tarefas extensas.

Integração dos achados

Relação entre telemetria gamificada, anamnese e notas clínicas

Verifica-se forte correspondência entre o declínio de rendimento verificado na telemetria dos jogos e os relatos da equipe escolar sobre fadiga atencional e distração.

Convergências observadas

A impulsividade detectada no Toca Rápido alinha-se diretamente aos relatos de impulsividade verbal e dificuldade em aguardar a vez em sala de aula.

Divergências e aspectos preservados

Excelente coordenação visomotora e raciocínio lúdico preservados, indicando bom potencial cognitivo global sem déficits motores de base.

Síntese integrada e parecer neuropsicológico

O quadro geral sugere perfil neuropsicológico caracterizado por instabilidade no controle inibitório e fatigabilidade atencional, sem prejuízos intelectuais globais.

14

Pontos para consideração profissional

Investigação e Foco Clínico

Investigar a relação entre a fatigabilidade cognitiva e os horários das matérias escolares mais complexas.

Adaptações no Ambiente Escolar

Implementar adaptações pedagógicas com subdivisão de tarefas longas em etapas curtas de 15 minutos.

Acompanhamento e Reavaliação

Reavaliação neuropsicológica e telemetria de acompanhamento em 6 meses para monitorar a curva evolutiva.

Instrumentos e Escalas Complementares

Aplicação de escalas comportamentais complementares respondidas por professores e familiares (ex: SNAP-IV).

Rotina, Sono e Fatores Ambientais

Orientação de higiene do sono e ajuste na rotina noturna para melhorar a prontidão atencional diurna.

Conclusão

Resultado dos jogos

Desempenho com variabilidade de latência moderada e taxa de comissão No-Go acima da média esperada para a faixa etária.

Resultado probabilístico

Probabilidade estimada de 68% para o perfil atencional avaliado através do modelo probabilístico de triagem.

Relação com contexto clínico

Convergência expressiva entre os biomarcadores digitais coletados e os comportamentos observados em consulta presencial.

Ressalvas e interpretação profissional

Este laudo representa um parecer técnico de triagem neuropsicológica e deve ser integrado à avaliação clínica qualitativa e multidisciplinar em consultório.

Compreender para cuidar.

16

Assinatura e rastreabilidade

Psicólogo(a) responsável

Dra. Mariana Costa

Registro profissional (CRP)

CRP 06/142589

Data de geração

01/10/2026

ID do relatório

TEKO-REP-2026-0984

Hash / identificador de autenticidade

SHA256: 8f9b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b

Autenticidade e Validade Técnica

Relatório clínico gerado eletronicamente sob responsabilidade técnica de **Dra. Mariana Costa (CRP 06/142589)** na data de 01/10/2026. O hash criptográfico acima garante a integridade dos dados telemétricos e do laudo emitido.